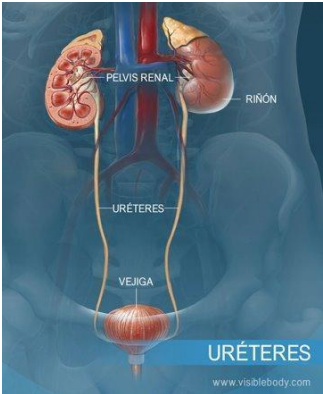


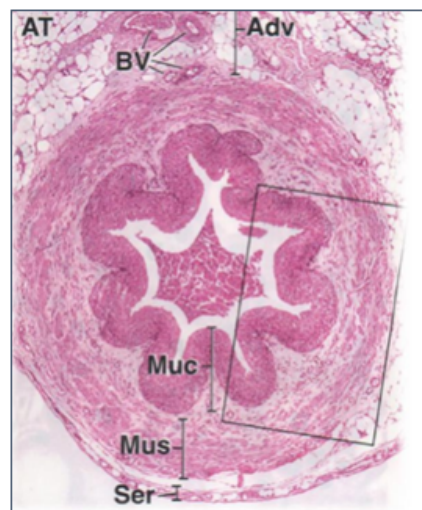


NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 4to Semestre 2025A		CÓDIGO:	NIVEL DE PRÁCTICA:
NOMBRE DEL DOCENTE : Samuel Humberto Palacio Peña		ESCENARIO DE PRÁCTICA:	NOTA:
ESPECIALIDAD:	CIRUJANO:	FECHA:	
NOMBRE DEL PACIENTE:		NÚMERO HISTORIA CLÍNICA:	EDAD DEL PX:
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO A REALIZAR: <i>REIMPLANTE URETERAL</i>			
PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA			
• ETAPA DE PLANEACIÓN:			
1.1. Objetivo Quirúrgico: (Hacer descripción) El reimplante uretral es una cirugía que corrige el flujo de orina a través de los uréteres (conductos por donde la orina desciende desde el riñón hasta la vejiga) 1.2. Anatomía y fisiología: (Hacer gráfico y descripción). Los uréteres son tubos largos y delgados formados de músculo liso. En los adultos, los uréteres miden 25-30 cm de largo, aproximadamente la longitud de una regla de 12 pulgadas. Los uréteres empujan cada pequeña cantidad de orina en forma de ondas de contracción, a baja presión. En la vejiga, cada uréter atraviesa la pared de la vejiga por una abertura que se cierra cuando la vejiga se contrae para evitar que la orina retroceda. 			



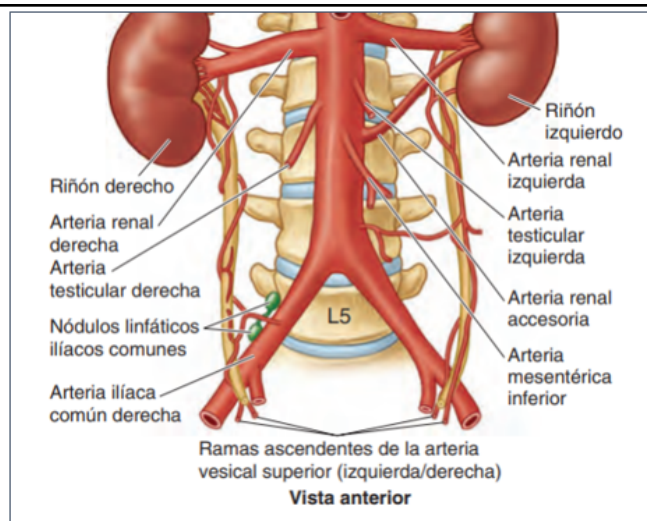
Capas

El uréter está compuesto por tres capas principales organizadas de adentro hacia afuera. La capa más interna es la mucosa, formada por un epitelio de transición (urotelio) que permite la distensión, y una lámina propia de tejido conectivo. Esta capa está en contacto directo con la orina. La siguiente es la capa muscular, compuesta por músculo liso dispuesto en dos capas: una longitudinal interna y una circular externa; en el tercio inferior del uréter puede haber una tercera capa longitudinal externa. Esta capa es responsable del movimiento peristáltico que impulsa la orina hacia la vejiga. Finalmente, la capa más externa es la adventicia, constituida por tejido conectivo laxo que contiene vasos sanguíneos, linfáticos y nervios, y que fija el uréter a las estructuras circundantes.



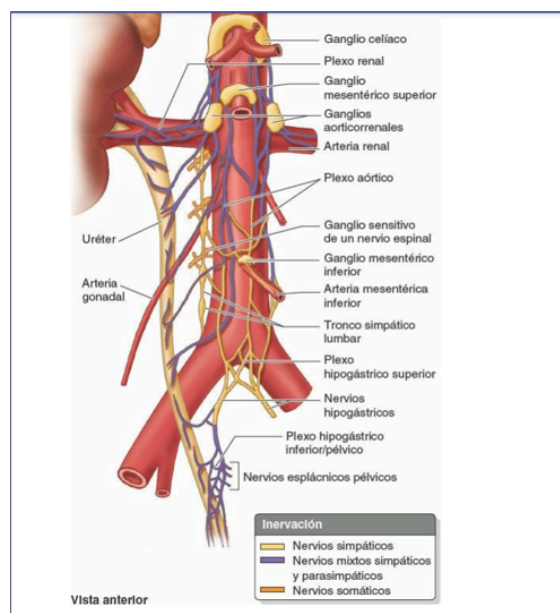
Irrigación uréter

La irrigación del uréter es segmentaria y proviene de varias arterias a lo largo de su trayecto desde el riñón hasta la vejiga. En el tercio superior, el uréter recibe ramas de la arteria renal; en el tercio medio, es irrigado por ramas de la arteria gonadal (testicular u ovárica), de la aorta abdominal y, en algunos casos, de la arteria iliaca común; en el tercio inferior, la irrigación proviene principalmente de ramas de la arteria iliaca interna, como la arteria vesical superior, arteria uterina en mujeres o la arteria vesical inferior en hombres. Las ramas arteriales forman una red en la adventicia del uréter antes de penetrar hacia las capas internas. Esta irrigación segmentaria es importante clínicamente, especialmente en cirugías, ya que el uréter depende de múltiples fuentes vasculares a lo largo de su trayecto.

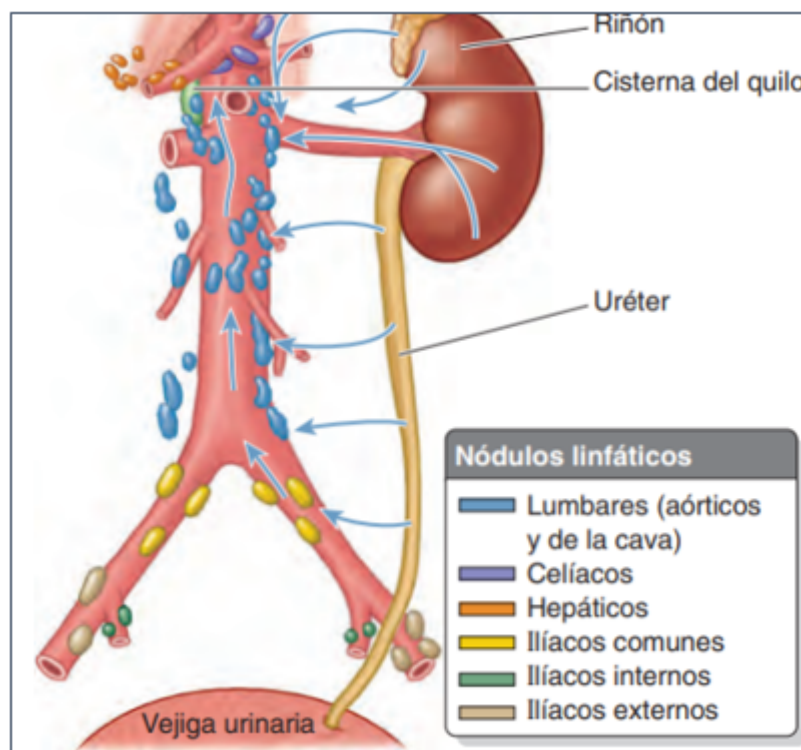


Inervación

La inervación del uréter es proporcionada por fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo, tanto simpáticas como parasimpáticas. Las fibras simpáticas provienen de los plexos renal, aórtico, hipogástrico superior e inferior, y tienen un papel en la modulación del dolor y del tono del músculo liso ureteral. Las fibras parasimpáticas se originan principalmente en el nervio vago (para la parte superior del uréter) y en los nervios espláncnicos pélvicos (S2-S4) para el tercio inferior. La transmisión del dolor ureteral viaja a través de las fibras simpáticas hasta los ganglios espinales toracolumbares (T10-L2), lo que explica por qué el dolor por cólico renal puede irradiarse a la espalda, flanco, abdomen o incluso a los genitales.



Drenaje Linfático uréter



FISIOLOGÍA

La fisiología del uréter se basa en su función principal de transportar la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga urinaria de manera continua y controlada. Este proceso se realiza mediante contracciones peristálticas del músculo liso ureteral, las cuales son rítmicas y espontáneas, iniciadas por células marcapaso ubicadas cerca de la pelvis renal. Las ondas peristálticas se producen entre 1 y 5 veces por minuto, dependiendo del volumen de orina. El uréter está compuesto por una capa muscular con disposición longitudinal interna y circular externa (y una capa longitudinal externa en el tercio distal), lo que permite un movimiento eficaz de la orina. Su control es autónomo, con innervación simpática que regula el tono del músculo liso y transmite el dolor, e innervación parasimpática que estimula la actividad contráctil. Además, el urotelio, un epitelio de transición que recubre el interior del uréter, actúa como barrera impermeable y detecta el estiramiento, ayudando a regular las contracciones. Finalmente, en su porción terminal, el uréter atraviesa de forma oblicua la pared de la vejiga, formando un mecanismo valvular que evita el reflujo de orina hacia los uréteres cuando la vejiga se llena.



1.3. Lista de chequeo:

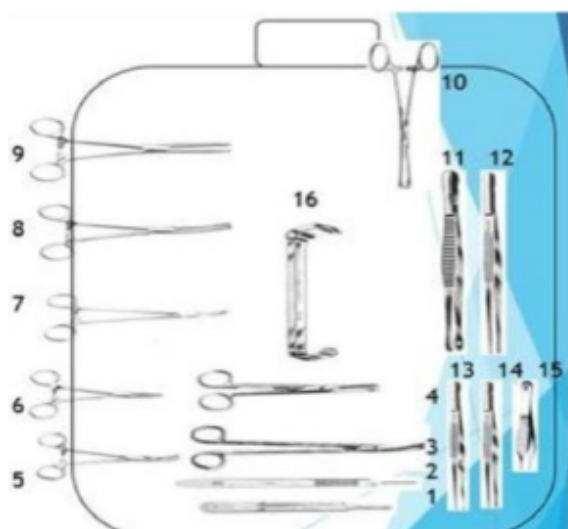
INSTRUMENTAL	EQUIPOS / DISPOSITIVOS MEDICO	SUTURAS Y AGUJAS	FARMACOS Y SOLUCIONES
Canasta general Canasta vascular Canasta de tórax Separadores de vena Lima	Paquete de ropa Electrobisturí Pera Caucho de succión Dren en cigarrillo Compresas Guantes Sonda nasogástrica 6 y 8 Torundas Hojas de bisturí 15 y 20 Gasas Apósitos	Piel: Polipropileno 2/0 o 3/0 con aguja $\frac{3}{8}$ de circulo cortante con aguja de 27 mm. TCS: Poliglactina 910 2/0 con aguja $\frac{1}{2}$ circulo redonda de 27 mm Fascia y musculo: Poliglactina 910 1 o 0 con aguja $\frac{1}{2}$ circulo redonda de 37 mm. Catgut cromado 4/0 o 5/0 con aguja 1/2 circulo redonda.	Solución salina



- ETAPA DE ORGANIZACIÓN:

- Arreglos de mesas de mayo y reserva (realizar esquema).

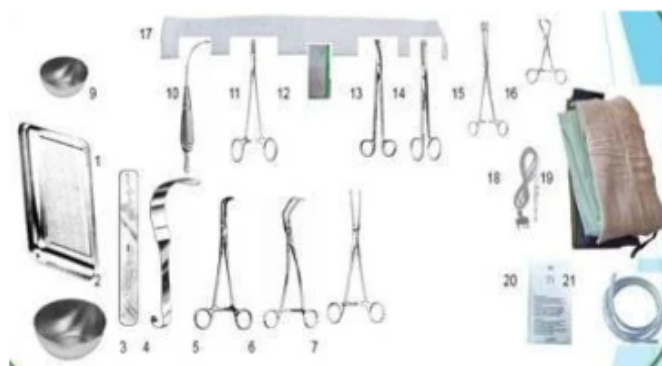
MESA DE MAYO



1. Mango de bisturí 4 - Hoja de bisturí #20
2. Mango de bisturí 3 - Hoja de bisturí #15
3. Tijeras de Metzembraum
4. Tijeras de Mayo recta
5. Pinzas Kelly curva
6. Pinzas Kelly recta
7. Pinzas Kelly Adson
8. Pinzas Roc hester curva
9. Pinzas Rochester recta
10. P inzas Allix
11. P inza de Disección Rusa
12. P inza de Disección sin garra larga
13. P inza de Disección con garra larga
14. P inza de Disección sin garra corta
15. D isección Adson con garra
16. S eparadores de Farabeuf

MESA DE RESERVA

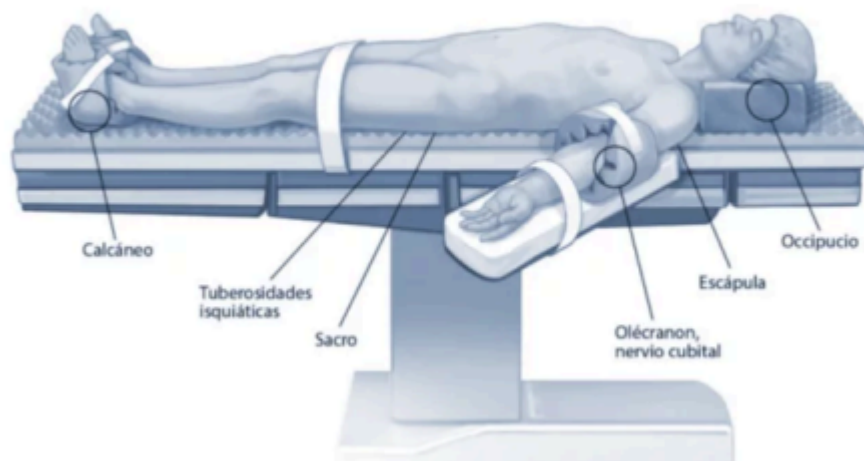
1. Equipo General
2. Coc a
- 3.Valva Maleable
4. deaver Angosto
5. Pinzas Cístico
- 6.Clamps de Satinsky
- 7.Clamps de Debakey
8. Coca con suero
9. Cánula de yankawer
- 10.Portaagujas
- 11.Suturas
- 12.Tijeras de Metzembraum Fina larga
- 13.Tijeras de Mayo larga
- 14.Pinza de Foester
- 15.pinza de campo de Backhouse
- 16.Compresa
- 17.Lapicero del Electrobisturi
- 18.Paquete de ropa
- 19.Guantes
- 20.Caucho de succión





2.2. Posición del paciente (Nombre y gráfico):

Decúbito supino





2.3. Ubicación del Equipo Quirúrgico (realizar gráfico):

POSICIÓN DE DECÚBITO SUPINO – REIMPLANTACIÓN URETERAL

UBICACIÓN DEL EQUIPO QUIRÚRGICO





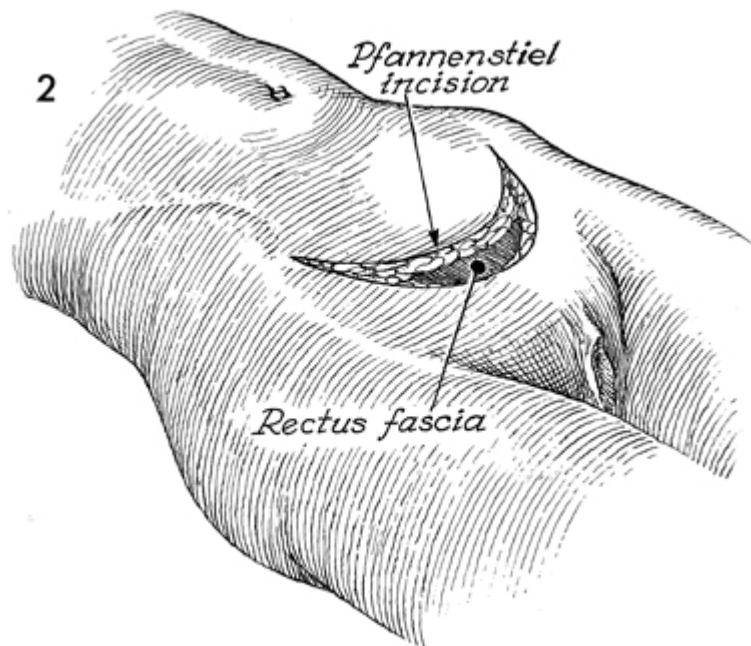
- **ETAPA DE EJECUCIÓN:**

o Anestesia (escribir el tipo de anestesia):

Anestesia General

o Incisión (escribir el tipo de abordaje y el nombre de la incisión):

incisión de Pfannenstiel





- o **Proceso Quirúrgico (Describir los pasos principales de la técnica médico quirúrgica con el instrumental a usar).**

TÉCNICA QUIRÚRGICA
Incisión Pfannenstiel aproximadamente de 2 cm por encima de la sínfisis del pubis
Se incide la piel con el bisturí y el tejido celular subcutáneo con el electrobisturí para exponer la fascia del músculo recto que se separan en la línea media, es decir, de manera vertical.
Se incide en la vejiga de manera vertical y en la cúpula vesical se introduce una gasa o compresa húmeda
Se reposiciona el auto retractor para visualizar el trigono vesical, se identifican los meatos y se introduce una sonda de 4 fr y se fija a la mucosa vesical
Se separa el uréter de la pared vesical alrededor del meato usando el electrobisturí y las tijeras
Se movilizan completamente o una porción suficiente del uréter y se sutura el defecto.
Creación del trayecto submucoso, Colocación del uréter, Reimplantación unilateral o bilateral
El uréter se coloca en el ángulo superior del hiato que se ha ampliado previamente, se hace creación de un trayecto submucoso en dirección al cuello, creación de un nuevo trayecto submucoso y de un nuevo hiato
Introducción del uréter a través del nuevo hiato Introducción del uréter en el trayecto submucoso Inserción del uréter en su lugar de inicio y cierre del orificio mucoso
Terminando de realizar la anastomosis, cerramos vejiga, primero sutura absorbible (3/0) para el segundo plano de la vejiga de igual manera. Sutura absorbible 3/0 Colocamos drenes de contrabertura, aproximamos los músculos, cierre de fascia Poliglactina 910 2/0 o 1 Dren Simple 3/0 o sutura absorbible y monofilamento 3/0 para piel. Se deja sonda Foley por la uretra/cistostomía



Técnica de cohen

- 1) Incisión del collarete mucoso
- 2) Disección ureteral
- 3) Creación del trayecto submucoso
- 4) Colocación del uréter
- 5) Reimplantación unilateral
- 6) Reimplantación bilateral

**Técnica de transposición técnica
de Glenn Anderson**

- 1) Técnica Glenn Anderson
 - 2) Disección ureteral por vía endovesical
 - 3) Disección de la mucosa alrededor del antiguo meato
 - 4) El uréter se coloca en el ángulo superior del hiato que se ha ampliado de forma intencionada
 - 5) Creación de un trayecto submucoso en dirección al cuello
- Aspecto final

Técnica de politano - leadbetter

- 1) Incisión del collarete mucoso
- 2) Disección ureteral
- 3) Creación del trayecto submucoso
- 4) Colocación del uréter
- 5) Reimplantación unilateral
- 6) Reimplantación bilateral



**Universidad
de Santander**
Personería Jur. 810 de 12/03/96 Min.Educación
VIGILADA MINEDUCACIÓN **UDES**

PROGRAMA DE INSTRUMENTACION QUIRURGICA

**PLANEAMIENTO QUIRURGICO PRACTICA
FORMATIVA
IQX-FT-003-BUC**

Versión: 01